Facteurs de risque liés aux actions et produits de santé

Antoine Duclos, Marie Zins, Sofiane Kab

Faculté de Médecine Paris Cité

Le contexte : les scandales sanitaires

- Le scandale du sang contaminé par le Virus de l'Immunodéficience Humaine (1980/90)

  Transfusés

  Utilisé dans les années 80 pour la fabrication des produits anti hémophiliques

- Celui de l'hormone de croissance extractive (1980)

  Produite à partir d'hypophyses contaminées par le prion responsable de la maladie de Creutzfeld-Jacob

- Le Médiator (2010)

  Anorexigène dérivé des amphétamines

  Rôle connu des dérivés des amphétamines délétère sur les valves cardiaques (remplacement valvulaire)

  Mis sur le marché pour le traitement du diabète et des dyslipidémies

  Utilisé comme coupe faim par certains médecins

Quelques définitions

- Le risque est une situation hypothétique qui évalue la probabilité de survenue d'un dommage. Il tient compte aussi de la gravité des conséquences potentielles.

  La prise de risque peut être réduite mais non supprimée : le risque zéro n'existe pas. On peut aussi la refuser, c'est-à-dire éviter de s'y exposer.

- Facteur de risque : toute caractéristique ou exposition d'un sujet qui augmente la probabilité de développer une maladie ou de souffrir d'un traumatisme. (OMS)

  Les facteurs de risque les plus importants au niveau mondial sont par exemple, le déficit pondéral, les rapports sexuels non protégés, la consommation de tabac ou d'alcool, l'eau non potable, l'insuffisance de l'hygiène ou de l'assainissement.

- Affection iatrogène :

  Une maladie, un évènement, un effet secondaire, sont une affection iatrogène lorsqu'ils sont occasionnés par le traitement médical qu'il y ait ou pas une erreur médicale

Plan du cours

I. Le risque iatrogène

- Concept
- Risques liés aux produits de santé
- Risques liés aux actions de santé

II. Les événements indésirables

- Définitions
- Epidémiologie descriptive

III. Déterminants des événements indésirables

IV. Gestion des risques d'événements indésirables

Plan du cours

I. Le risque iatrogène

Concept

Risques liés aux produits de santé

Risques liés aux actions de santé

II. Les événements indésirables

Définitions

Epidémiologie descriptive

III. Déterminants des événements indésirables

IV. Gestion des risques d'événements indésirables

Le risque iatrogène

CONCEPT

Le risque iatrogène : émergence du concept

- La gestion du risque s'est développée aux USA 1950 :

  Réduire le risque de mise en cause de la responsabilité des professionnels, les actions en dommages et intérêts et le coût des assurances pour négligence médicale

- Mise en cause de plus en plus fréquente de la responsabilité des professionnels (négligences, erreurs)
- Objectifs :

  Réduire le nombre d'actions en justice

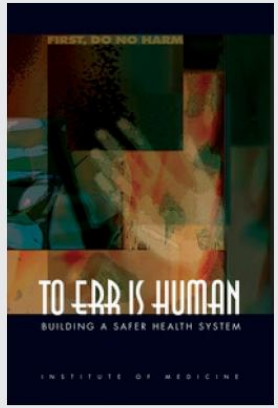
  Freiner l'augmentation du montant des primes d'assurance

- Initialement centré sur les soins et la pratique en milieu hospitalier (chirurgie, réanimation, obstétrique, urgences)
- Développement disciplinaire sur la sécurité des soins et du patient

Le risque iatrogène : émergence du concept

Un tournant avec la publication par l'institut de médecine américain du rapport "To err is human" (USA, 1999)

- "… 44 000 à 98 000 personnes décèdent chaque année dans les hôpitaux de court séjour aux USA suite à une négligence ou une erreur médicale …"
- 2 à 4% de tous les décès aux États-Unis sont causés par des erreurs médicales
- Comparativement, <50 000 personnes décédées de maladie d'Alzheimer et 17 000 d'usage ilicite de drogue
- l'Agence pour la politique et la recherche des soins de santé devient l' Agence pour la recherche et la qualité des soins de santé



Linda T. Kohn, Janet M. Corrigan, and Molla S. Donaldson, Editors; Committee on Quality of Health Care in America, Institute of Medicine

Le risque iatrogène : émergence du concept

- Ces estimations ont été obtenues par extrapolation à l'ensemble du territoire américain des résultats d'études épidémiologiques conduites en Californie et dans l'État de New York *(Harvard Medical Practice Study)* dans les années 1980 et un peu plus tard en Utah et au Colorado.
- Ces études ont permis de :

  d'estimer le **taux d'incidence** des événements iatrogènes

  dresser une **typologie** des risques iatrogènes (medicament, infection, operation, etc.)

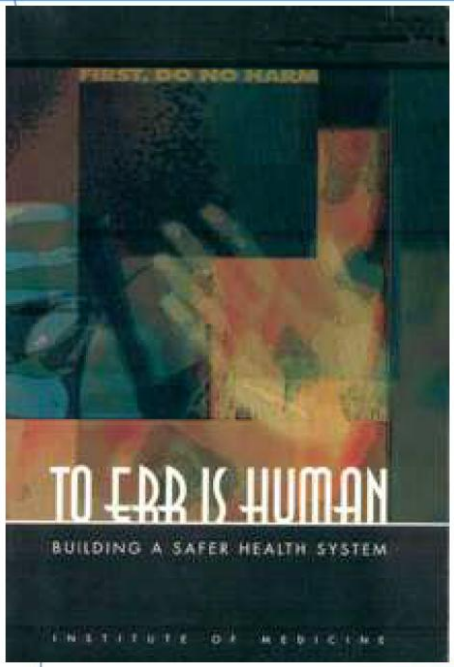
  d'estimer la part d'événements **évitables et/ou graves**

  d'identifier les **lieux et facteurs de risque** associés aux événements iatrogènes

  d'évaluer les **conséquences et coûts** engendrés par les événement iatrogènes

Rencontres HAS 2007

LA MONTÉE EN PUISSANCE DES APPROCHES SYSTÉMIQUES



- Les erreurs médicales constituent un sérieux problème
- Leur première cause n'est pas l'incompétence des acteurs, mais la mauvaise qualité du système médical
- On doit reconcevoir globalement le système médical
- On doit changer la façon de former nos médecins
- On doit faire de la sécurité médicale une vraie priorité nationale
- On n'atteindra pas ces objectifs sans une démarche scientifique

www.iom.org

La Sécurité du Patient

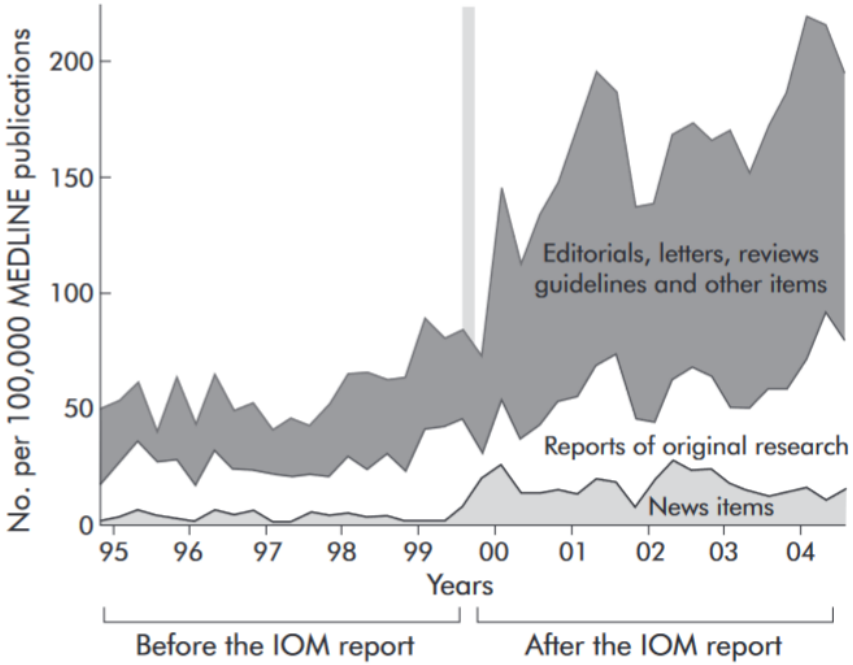
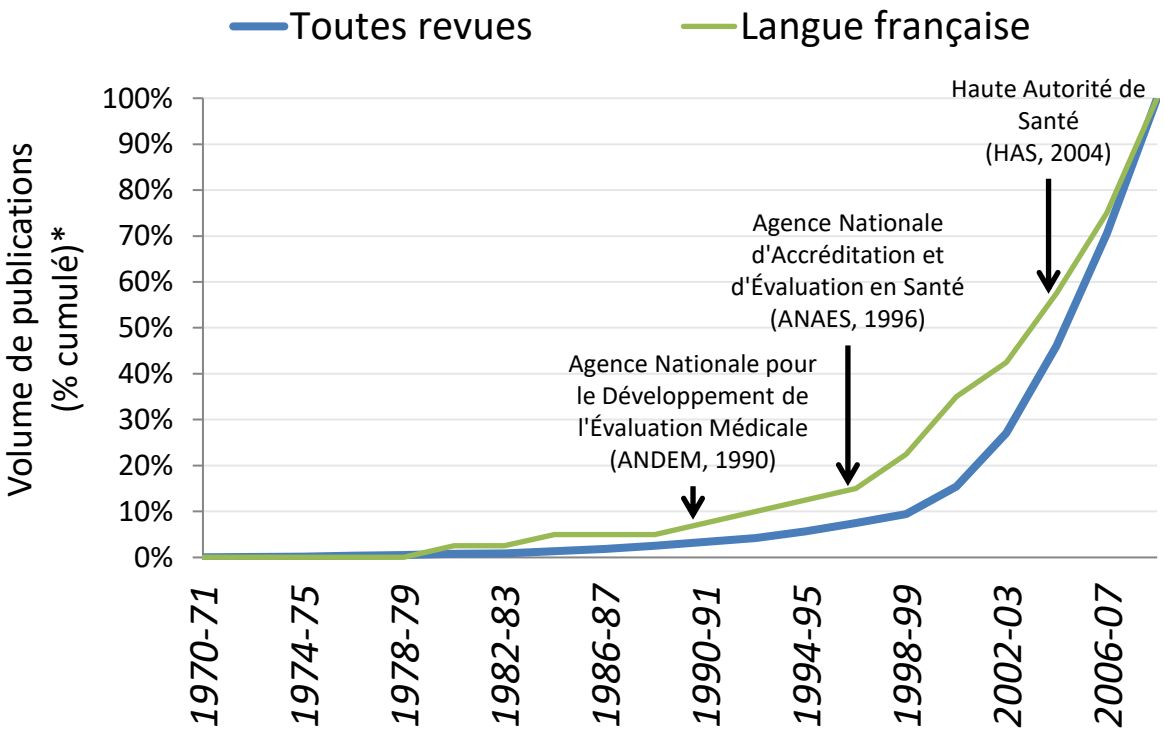


Figure 1 Patient safety publications before and after publication of the IOM report ''*To Err is Human*''.

Stelfox HT, Qual Saf Health Care 2006

La Sécurité du Patient



** Source PubMed ('Patient Safety')*

Le risque iatrogène

RISQUES LIÉS AUX PRODUITS DE SANTÉ

ansm agence - Yahoo France Ré | Accueil - ANSM

https://ansm.sante.fr

ansm
Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé

Domaine médical | Produit de santé

- Qui sommes-nous ?
- Actualités
- Bulletin officiel des actes, décisions et avis
- Disponibilité des produits de santé
- Vos démarches
- Documents de référence
- Informations de sécurité
- Dossiers thématiques
- Espace presse
- Contactez-nous



• A la une

Tramadol et codéine devront être prescrits sur une ordonnance sécurisée dès le 1er décembre

Informations de sécurité

04/10/2024 INFORMATION AUX UTILISATEURS
DISPOSITIFS MÉDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO
Réactifs Alinity m HR HPV AMP Kit & Alinity m STI AMP Kit – Abbott Molecular

04/10/2024 INFORMATION AUX UTILISATEURS
DISPOSITIFS MÉDICAUX
Orthopédie dentaire et faciale – Intercepteur labial pédiatrique avec butée - D595010P – Orthoplus SAS

03/10/2024 RAPPEL DE PRODUIT
DISPOSITIFS MÉDICAUX
Sérum physiologique « Santecare » - Zhuhai Ninuo Biotechnology

02/10/2024 RISQUES MEDICAMENTEUX
MÉDICAMENTS
Caspofungine : l'ANSM recommande de ne pas utiliser de membrane dérivée du polyacrylonitrile chez les patients en soins intensifs sous hémofiltration

01/10/2024 INFORMATION AUX UTILISATEURS
DISPOSITIFS MÉDICAUX
IRM – Systèmes Evolution Upgrade 3.0T, Ingenia 1.5T, Ingenia 3.0T, Ingenia 3.0T CX, Ingenia Ambition S, Ingenia Ambition X, Ingenia Elition X – Philips

01/10/2024 INFORMATION AUX UTILISATEURS

Rechercher

18:45
04/10/2024

Agence Nationale de Sécurité des Médicaments et des produits de santé (ANSM)

- **Pharmacovigilance** pour les médicaments à usage humain et les matières premières à usage pharmaceutique
- **Addictovigilance** pour les substances psychoactives dont les stupéfiants et les psychotropes
- **Hémovigilance** pour l'ensemble de la chaîne transfusionnelle du prélèvement du donneur au suivi post-transfusionnel du receveur de produits sanguins labiles
- **Matériovigilance** pour les dispositifs médicaux et les produits thérapeutiques annexes
- **Biovigilance** pour l'ensemble de la chaîne de greffe du prélèvement du donneur au suivi post-greffe du receveur d'organes, de tissus, de cellules d'origine humaine excepté le sang et les gamètes, et pour les produits thérapeutiques annexes
- **Réactovigilance** pour les dispositifs de diagnostic in vitro
- **Cosmétovigilance** pour les produits cosmétiques
- Vigilance pour les produits de **tatouages**
- Vigilance applicable aux **recherches biomédicales**

Les risques liés aux produits de santé

Utilisation normale

Il y a toujours un risque

Balance bénéfice-risque à évaluer avant toute utilisation d'un produit de santé

Modalités de prescription sub-optimale

L'excès de traitement : Overuse

Utilisation de médicaments prescrits en l'absence d'indication ou d'efficacité démontrée

La prescription inappropriée: Misuse

Utilisation de médicaments hors AMM

L'insuffisance de traitement: Underuse

Absence d'instauration d'un traitement efficace chez les sujets ayant une pathologie pour laquelle une ou plusieurs classes médicamenteuses ont démontré leur efficacité

Risque en utilisation normale

Le rôle du principe actif du médicament

- Effets dits «secondaires», *Ex : saignement sous anticoagulant*

Mauvaise conception du produit

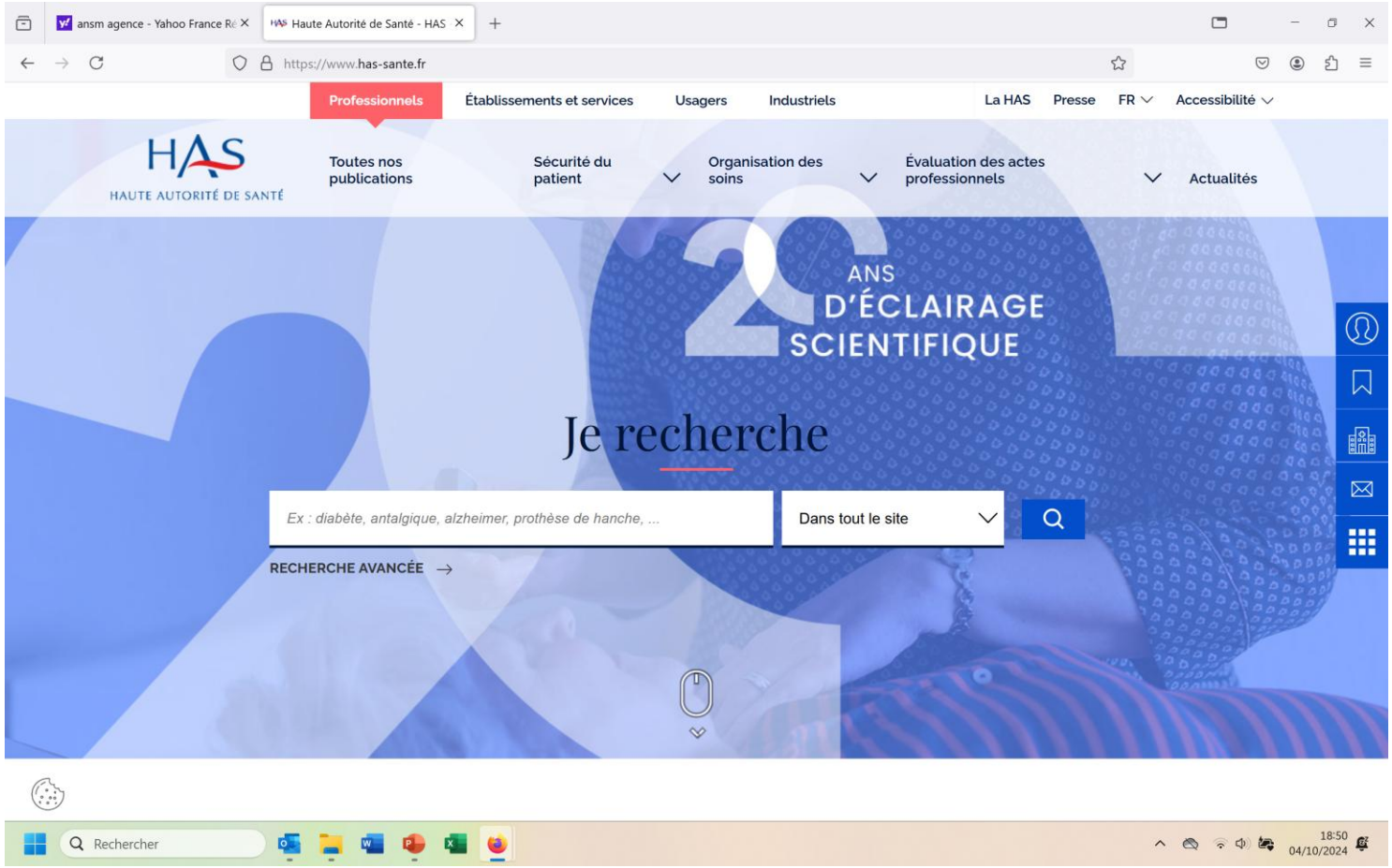
- *Ex : espacement des barreaux de barrières de lit*

Malfaçon d'un produit ou d'un lot de produit

- Médicament, Vaccin, Dispositif médical…

Le risque iatrogène

RISQUES LIÉS AUX ACTIONS DE SANTÉ


ansm agence - Yahoo France Re
Haute Autorité de Santé - HAS
https://www.has-sante.fr
Professionnels
Établissements et services
Usagers
Industriels
La HAS
Presse
FR
Accessibilité
HAS
HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ
Toutes nos publications
Sécurité du patient
Organisation des soins
Évaluation des actes professionnels
Actualités
20 ANS D'ÉCLAIRAGE SCIENTIFIQUE
Je recherche
Ex : diabète, antalgique, alzheimer, prothèse de hanche, ...
Dans tout le site
RECHERCHE AVANCÉE
Rechercher
18:50
04/10/2024

Actes et procédures

- Intervention chirurgicale +++
- Autres actes invasifs
  - Radiologie interventionnelle
  - Endoscopie
  - Manœuvres obstétricales
  - Pose de cathéter, injection, perfusion, intubation - ventilation assistée
  - Dialyse
  - Radiothérapie
  - Imagerie avec injection produit de contraste
  - Sondages urinaire, gastrique

Risques au cours des soins

Evènement indésirable survenu par administration de soins non optimaux = par commission

- Exemple: *Femme de 56 ans. Hémarthrose dans les suites d'une prothèse totale de genou. Patiente à haut risque thromboembolique mise d'emblée sous antithrombotique à dose non justifiée.*

Evènement indésirable survenu par défaut de soins = par omission

- Exemple: *Homme de 76 ans hospitalisé en réanimation. Équipe soignante en effectif insuffisant. Apparitions d'escarres.*

Pratiques et actes médicaux

- Les spécialités à risque car plus d'actes à risques

  chirurgie, anesthésie-réanimation, médecine d'urgence, médecine interventionnelle, cancérologie et hématologie

- Il existe des actes sur des populations pour lesquels le risque est socialement perçu comme intolérable

  Nouveau-nés, mères, enfants

  Chirurgie esthétique

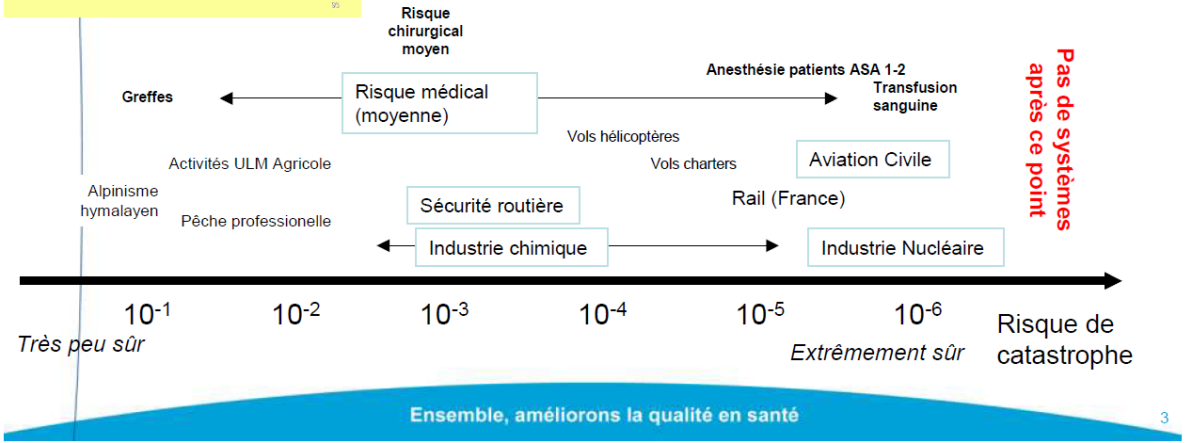
Rencontres HAS 2007

L'AMPLEUR DE LA TÂCHE



Des chiffres comparables dans les pays occidentaux :

- **1 évènement indésirable pour 10 entrées à l'hôpital**
- **40% évitable**



Ensemble, améliorons la qualité en santé

Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du Travail (ANSES)

Nutrivigilance	Résultant de la consommation de complément(s) alimentaire(s) ou de certain(s) produit(s) alimentaire(s)	ANSES**
Vigilance vétérinaire	Résultant de l'utilisation de médicament vétérinaire chez l'animal et pour les personnes en contact avec le médicament et l'animal traité	ANSES
Toxicovigilance	Résultant des effets toxiques pour l'homme d'un produit, d'une substance ou d'une pollution	ANSES

Plan du cours

I. Le risque iatrogène

- Concept
- Risques liés aux produits de santé
- Risques liés aux actions de santé

II. Les événements indésirables

- **Définitions**
- **Epidémiologie descriptive**

III. Déterminants des événements indésirables

IV. Gestion des risques d'événements indésirables

Les événements indésirables

DÉFINITIONS

Les événements indésirables (EI)

La notion d'**événement indésirable (EI)** est très large

Pour chaque action conduite, elle concerne tous les facteurs non souhaités qui empêchent d'atteindre l'objectif recherché

La notion de **gravité** n'a pas vraiment de définition précise

un événement indésirable est grave lorsqu'il impacte fortement la sécurité des biens ou des personnes

Les événements **sanitaires** indésirables

EI qui se produisent dans le champ sanitaire (médecine de ville, établissement de santé, structure médicosociale) ou qui sont susceptibles d'affecter la santé d'une personne

Les événements sanitaires indésirables

On distingue les

- Evènements sanitaires Indésirables **Associés aux Soins (EIAS)**
- Evènements sanitaires Indésirables **non liés aux soins**

  Episode de violence entre usagers ou d'usagers envers des professionnels

  Falsification d'ordonnance

  Episode infectieux épidémique hors structure de soins

  Intoxication d'origine alimentaire ou environnementale

Un Evénement sanitaire Indésirable Associé aux Soins (EIAS)

1. Peut faire suite à l'**exposition à un produit de santé**

- L'exposition à un produit acheté en pharmacie, dans le commerce ou sur Internet
- L'événement indésirable peut être consécutif à sa manipulation, sa consommation, ses conditions d'utilisation
- L'événement indésirable peut être déjà connu et inscrit dans la notice ou le mode d'emploi

2. Peut concerner un **acte de soins**

- Acte à but diagnostic, thérapeutique ou préventif ainsi que les actes médicaux à visée esthétique
- Actes effectués par un professionnel de santé (médecin, pharmacien, sage-femme, infirmier…)

Evènements indésirables médicamenteux (EIM)

- **EIM les plus fréquents :** allergiques (cutanées), digestifs (nausées, vomissements, troubles du transit, hépatites), cardiovasculaire (hypotension), neuropsy (somnolence, confusion, troubles de l'équilibre)…
- **EIM les plus graves :** choc anaphylactique, hémorragies, insuffisance rénale aigue, troubles hémato (leucopénies, thrombopénies), hypoglycémies, troubles hydroélectrolytiques…
- **Médicaments les plus souvent en cause:** cardiovasculaire (diurétiques et anti-hypertenseurs, digitaliques, anti-arythmiques), anticoagulants, psychotropes (anxiolytiques, antidépresseurs, neuroleptiques), antibiotiques, AINS, antidiabétiques…

Iatrogénie médicamenteuse

Toute réponse néfaste et non recherchée à un médicament survenant à des doses utilisées chez l'homme à des fins de prophylaxie, de diagnostic et de traitement

Facteurs de risque de iatrogénie médicamenteuse souvent multiples

1. **En rapport avec le principe actif du médicament** : Longue demi-vie d'élimination (Benzodiazépine), Dépendance, Tératogénicité (Dépakine), Polymédication (interactions médicamenteuse), Commercialisation récente (absence de recul en vie réelle)
2. **En rapport avec le professionnel de santé** : Non respect du bon usage du médicament, Méconnaissance de comorbidités (insuffisance rénale…), Surveillance insuffisante / absence de réévaluation, Nombre de prescripteurs (polyprescripteurs) non harmonisés
3. **En rapport avec le patient :** Polymorbidité et fragilité (personnes âgées), Enfants, Grossesse, Antécédents d'iatrogénie, Automédication non encadrée et non déclarée (ex. Anti-inflammatoires non stéroidiens, AINS), Erreur d'observance (sevrage, surdosage)

Infection associée aux soins

Infection survenant au cours de la prise en charge d'un patient par un professionnel de santé

N'était pas présente ni en incubation au début de la prise en charge

Les **infections nosocomiales** font partie des infections associées aux soins :

- Elles sont contractées dans un **établissement de santé**. Le patient n'en était pas porteur à l'admission
- L'infection est considérée comme nosocomiale si elle apparaît après un **délai de 48 heures** d'hospitalisation.
- Ces infections peuvent être directement liées aux soins (au cours d'un acte invasif, par exemple) ou survenir lors de l'hospitalisation, indépendamment de tout geste médical (épidémie…).
- Les infections nosocomiales concernent aussi bien les malades, que les visiteurs ou le personnel de santé.
- Une infection qui se révèle après la sortie de l'établissement de soins peut très bien être nosocomiale.
    - Toute infection du site opératoire dans les 30 jours suivant une intervention chirurgicale est a priori nosocomiale
    - Ce délai est porté à un an pour les infections survenant en cas de mise en place de matériel prothétique

Classification

1. Evénement Indésirable **Grave** (EIG) associé aux soins

   EIAS associé a des critères de gravité (cause ou prolongation du séjour hospitalier, incapacité à la fin de l'hospitalisation, handicap, risque vital, décès)

2. Evénement indésirable **évitable** associé aux soins

   Tout événement qui peut être prévenu si les soins avaient été conformes à la prise en charge considérée comme satisfaisante avec un niveau d'incertitude

3. Événement **porteur de risque** associé aux soins

   Tout événement indésirable survenant dans le cours de réalisation d'une action et qui finit par se neutraliser (spontanément ou par action volontariste) avant même la survenue de conséquences. (Presque accident)

Niveaux de gravité d'un événement EIAS

Niveau 1 « mineur »	L'EIAS provoque un désagrément ou une insatisfaction au patient. *Par exemple : erreur d'identification d'un patient rattrapée avant qu'on lui donne son médicament*	EI non grave
Niveau 2	L'EIAS impacte le patient sans mise en jeu de sa sécurité et sans interrompre sa prise en charge initiale. *Par exemple : examen réalisé mais pas à la bonne personne*	
Niveau 3 « majeur »	Une prise en charge spécifique ou une surveillance accrue sont nécessaires sans pour autant interrompre la prise en charge. *Par exemple : chute d'un patient avec plaie du front nécessitant des points de suture*	EI de gravité intermédiaire
A partir du niveau 4 : la prise en charge de l'EIAS prend le dessus sur la prise en charge de la pathologie initiale. La prise en charge initiale doit être reportée.		
Niveau 4 « critique »	L'EIAS est récupéré au final avec des conséquences réversibles. *Par exemple : administration d'un mauvais médicament entrainant une détresse respiratoire et une hospitalisation*	Événement indésirable grave
Niveau 5 « catastrophique »	L'EIAS est difficilement récupérable. On pourra au mieux atténuer ses conséquences qui restent cependant importantes et irréversibles. *Par exemple : erreur de site chirurgical avec ablation du rein fonctionnel au lieu du rein atteint*	

Remarques +++

Aléa thérapeutique : événement indésirable survenu en dépit de soins conformes et à une prise en charge satisfaisante

- Une part importante des événements indésirables est la conséquence de risques inhérents aux processus de soins

La survenue d'un événement indésirable ne signifie pas nécessairement qu'une erreur ou négligence ait été commise dans la prise en charge du patient.

La notion « d'évitabilité » est basée sur l'analyse des conditions de survenue d'un événement indésirable, au regard des connaissances disponibles.

- L'évolution des connaissances et des pratiques peut modifier dans le temps l'appréciation du caractère évitable d'un événement : ce qui est jugé inévitable aujourd'hui pourrait ne plus l'être à l'avenir

Les événements indésirables

EPIDÉMIOLOGIE DESCRIPTIVE

Evènements Indésirables Graves (EIG) à l'hôpital

Taux d'incidence **des EIG survenus en cours d'hospitalisation**

(pour 1000 journées d'hospitalisation)

	Taux Incidence	$IC_{95\%}$
EIG	6,2	5,1 à 7,3
EIG évitables	2,6	1,8 à 3,3

EIG évitables	
Procédures / actes invasifs*	1,7
Produits de santé	1,1
Infections associées aux soins	0,9
Total	2,6†

* interventions chirurgicales, anesthésies, actes de radiologie interventionnelle, endoscopies, biopsies, ponctions, pose de cathéters centraux, et intubations.

† la somme est supérieure au total car les causes ne sont pas exclusives (un patient peut avoir deux EIG de différentes causes)

Au total en France

275 000 à 395 000 EIGS survenus en cours d'hospitalisation

95 000 à 180 000 EIGS évitables survenus en cours d'hospitalisation

Enquête nationale sur les EI associées aux soins (ENEIS 2009, DREES)

Hospitalisations causées par un EIG

En 2009, 4,5% de l'ensemble des séjours hospitaliers étaient causés par un événement indésirable grave

dont 2,6 % (la moitié) étaient causés par un événement indésirable grave évitable

26 % des événements indésirables graves à l'origine d'une hospitalisation étaient directement consécutifs à une hospitalisation précédente.

Cela représente au total

- 330 000 à 490 000 hospitalisation causée par un EIG par an
- 160 000 à 290 000 hospitalisation causée par un EIG évitable par an

Coûts des EI associés aux soins à l'hôpital

T2 **Surcoût et allongement de durée des séjours par PSI dans l'ENCC 2007**

Événements indésirables associés aux soins	ENCC				
	Effectifs	Allongement de la durée moyenne de séjour	Intervalle de confiance à 95 %	Surcoûts	Intervalle de confiance à 95 %
PSI 3 Escarres	3 456	11,2	± 0,83	5 612 €	± 656
PSI 5 Oubli corps étranger	89	2,5	± 3,05	2 156 €	± 2879
PSI 7 Infections	915	14,7	± 1,84	10 950 €	± 1690
PSI 10 Désordres physiologiques	4 228	7,3	± 0,59	10 273 €	± 629
PSI 12 Embolie pulmonaire	3 003	5,0	± 0,59	4 300 €	± 578
PSI 13 Septicémie	1 852	19,7	± 1,44	20 838 €	± 1317
PSI 15 Lacération ou piqûre accidentelle	1 220	1,2	± 0,88	1 723 €	± 902
PSI 18/19 Traumatisme obstétrical	415	0,7	± 0,11	529 €	± 32

Source: Étude nationale de coûts à méthodologie commune (ENCC) 2007.

Télécharger les données: www.irdes.fr/Donnees/Qes171_SurcoutEvenementsIndesirables.xls

Evènements indésirables liés aux soins primaires / ambulatoires

- Les EIAS sont fréquents (1 EIAS /2 jours par médecin) mais très rarement graves
- Les EIAS surviennent principalement au cabinet de ville ou au domicile du patient
- Patients ayant souvent plusieurs maladies
- EIG évitables le plus souvent associés à

  des produits de santé, notamment médicaments

  une procédure, essentiellement actes invasifs

  des infections liées aux soins

Etude ESPRIT 2013

Evénements Indésirables Associés aux Soins (EIAS)

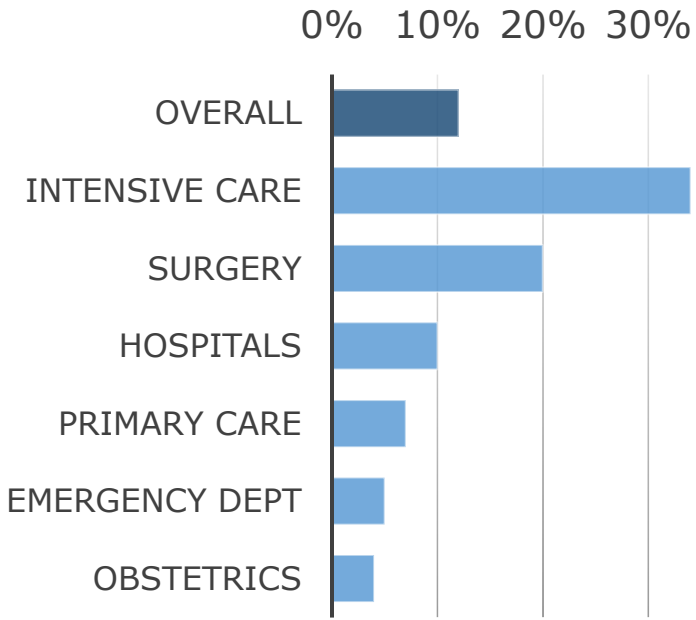
Les erreurs médicales seraient la 3e cause de décès…

Makary, BMJ 2016

La moitié des EIAS seraient évitables…

De Vries, BMJ Qual Saf 2008

La coût de prise en charge des EIAS s'élève potentiellement à 1% du PIB français



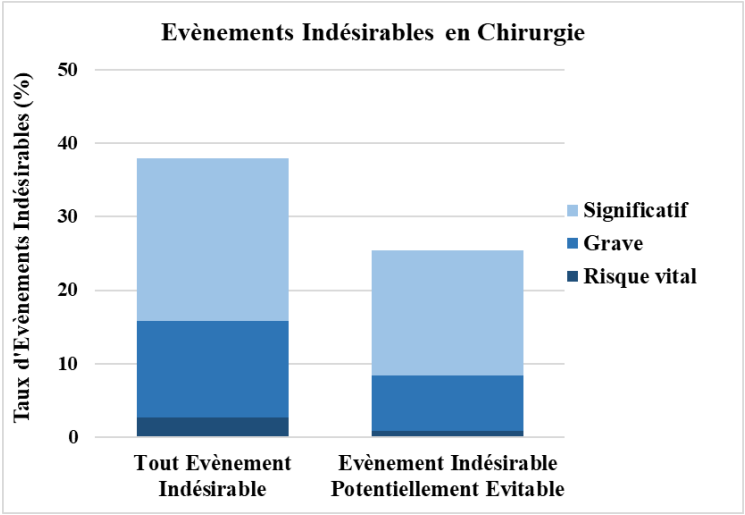
Panagioti, BMJ 2019

Evénements Indésirables Associés aux Soins (EIAS)

RESULTS

In a random sample of 2809 admissions, we identified at least one adverse event in 23.6%. Among 978 adverse events, 222 (22.7%) were judged to be preventable and 316 (32.3%) had a severity level of serious (i.e., caused harm that resulted in substantial intervention or prolonged recovery) or higher. A preventable adverse event occurred in 191 (6.8%) of all admissions, and a preventable adverse event with a severity level of serious or higher occurred in 29 (1.0%). There were seven deaths, one of which was deemed to be preventable. Adverse drug events were the most common adverse events (accounting for 39.0% of all events), followed by surgical or other procedural events (30.4%), patient-care events (which were defined as events associated with nursing care, including falls and pressure ulcers) (15.0%), and health care–associated infections (11.9%).

Bates, NEJM 2023



Duclos, BMJ 2024

Plan du cours

I. Le risque iatrogène

- Concept
- Risques liés aux produits de santé
- Risques liés aux actions de santé

II. Les événements indésirables

- Définitions
- Epidémiologie descriptive

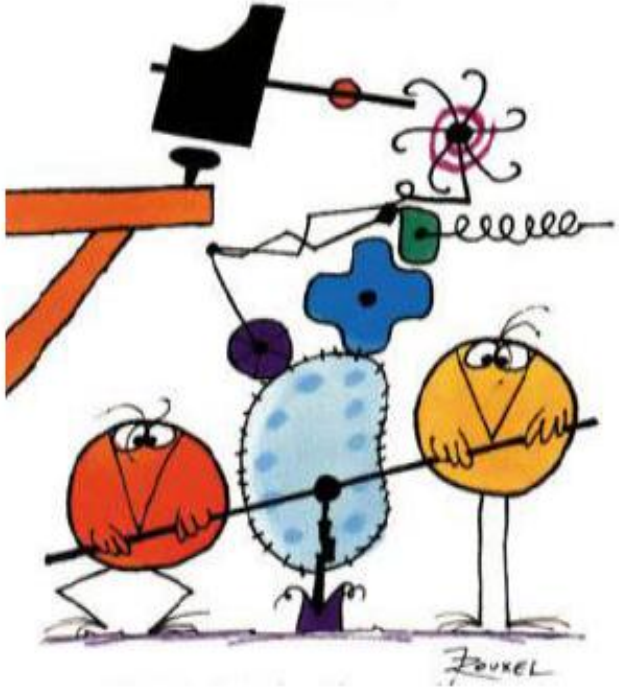
III. Déterminants des événements indésirables

IV. Gestion des risques d'événements indésirables

Déterminants des événements indésirables

Défaillance d'un système complexe….

- Ensemble d'éléments interagissant entre eux selon certains principes
- Déterminé par
  - la nature de ses éléments constitutifs
  - les interactions entre les éléments



Spécificité des actions médicales dans un système complexe

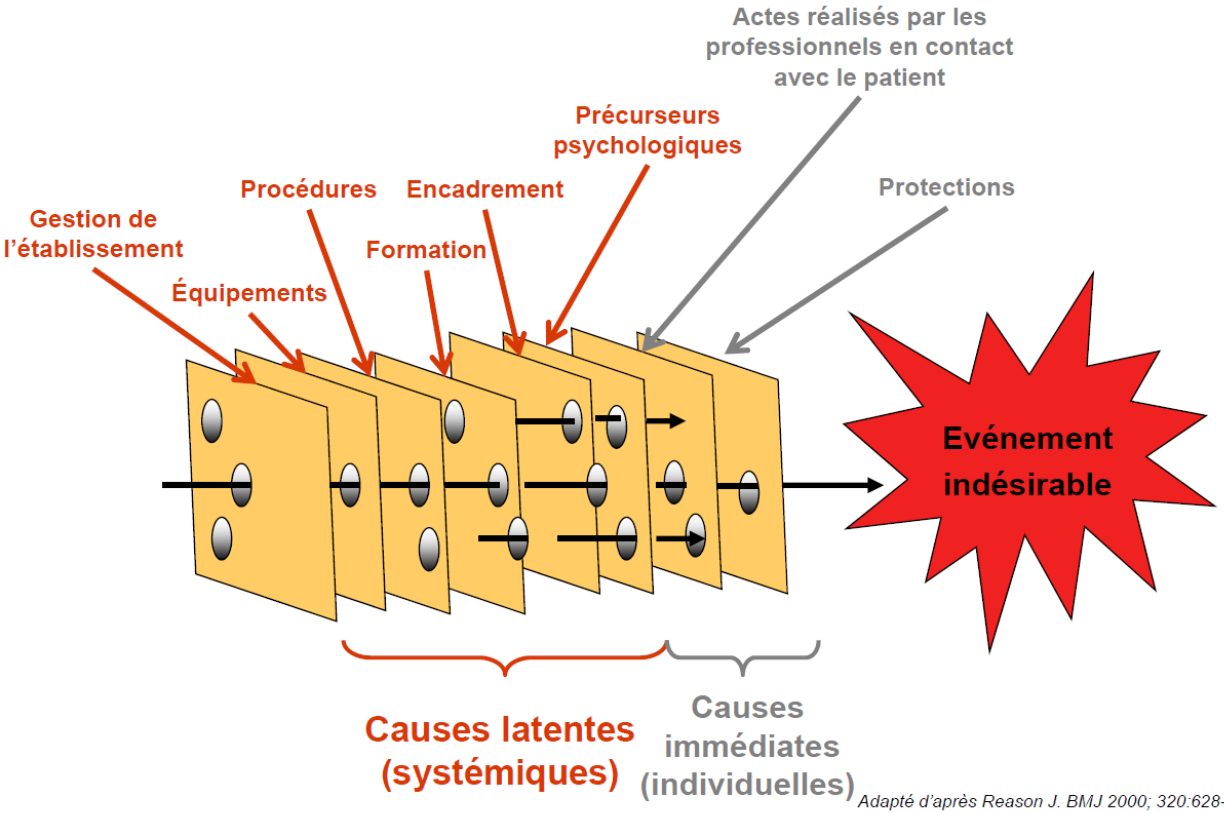
- Organisation des soins pour répondre aux besoins croissants de la population à grande échelle sous contrainte budgétaire
- Pratiques et volume d'actes médicaux complexes à haut risque pour le patient
- Fragmentation du processus de soins impliquant de nombreux acteurs
- Sur spécialisation en silot
  - organes et systèmes (cœur, peau, appareil urinaire etc.)
  - techniques (chirurgie, imagerie, biologie etc.)
  - catégories de patients (pédiatrie, gynécologie, gériatrie)
- Intégration rapide des progrès technologique et innovations liées aux produits de santé
- Interaction entre professionnel de santé - patient

Deux théoriciens pour analyser la chaîne causale des évènements indésirables

- Donabedian (1970 1990)
  - Structure -> Processus -> Résultat
  - Conduit à la certification des structures et à la rédaction de procédures

- Reason (1980 2000)
  - Cheese model, causes latentes (systémiques) et immédiates (individuelles)
  - Conduit à l'analyse des évènements dans une approche systémique plus large

Déterminants de la défaillance du système



Adapté d'après Reason J. BMJ 2000; 320:628-670

Cheese model Reason 1992

Déterminants individuels et systémiques

Causes individuelles (causes immédiates) – 20%	Causes systémiques (causes latentes) – 80%
Défaut d'aptitude	<u>Gestion des compétences</u> - Absence de professionnel compétent - Déficit de contrôle des compétences - Défaut de formation continue
Défaut d'attention, fatigue	<u>Organisation du travail</u> - Absence de repos de sécurité - Durée excessive de travail sans repos - Gestion du personnel inadéquate
Décision non conforme aux référentiels professionnels	<u>Gestion des documents qualité</u> - absence de protocole - protocole non accessible - protocole obsolète <u>Encadrement</u> - Défaut de supervision

Facteurs contributifs des EIG évitables à l'hôpital

Répartition des facteurs contributifs des EIG évitables identifiés pendant l'hospitalisation - 2009

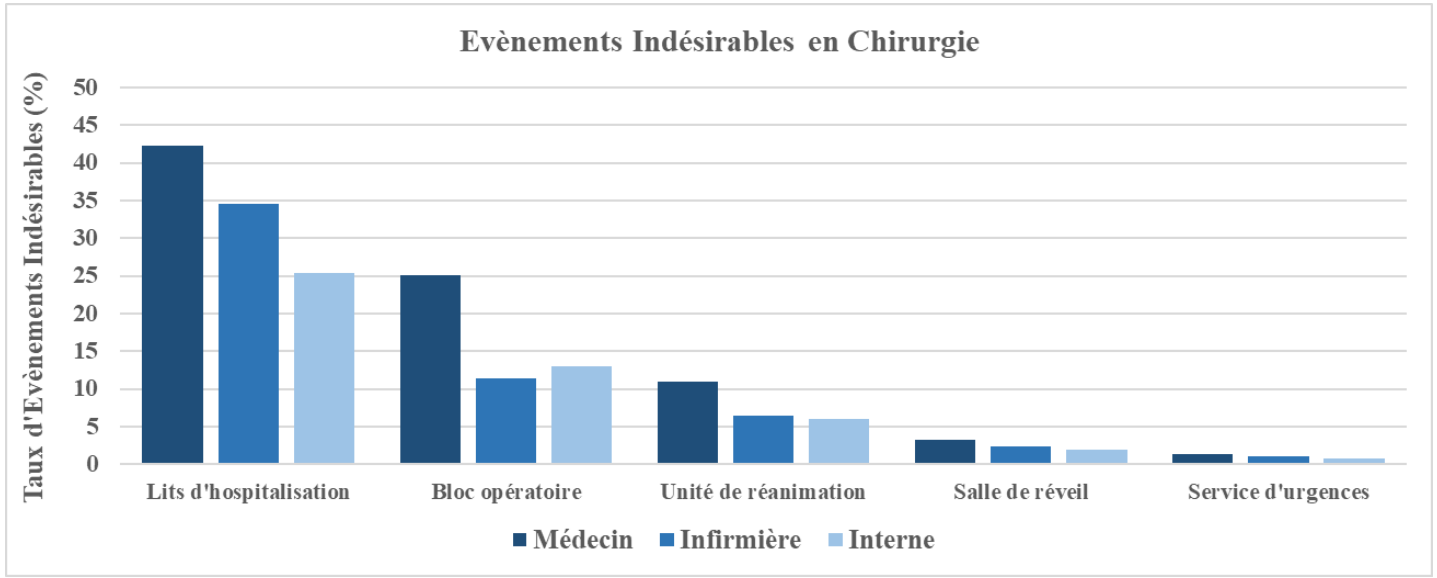
Facteurs ayant favorisé l'EIG	EIG évitables (n=87)	
	Nombre	(%)
Défaillance humaine d'un professionnel	24	27,6
Supervision insuffisante des collaborateurs	23	26,4
Mauvaise définition de l'organisation et de la réalisation des tâches	11	12,6
Communication insuffisante entre professionnels	21	24,1
Composition inadéquate des équipes	14	16,1
Infrastructures inappropriées	15	17,2
Défaut de culture qualité	7	8

Les pourcentages calculés correspondent aux rapports des effectifs observés dans l'enquête et ne tiennent pas compte des redressements effectués pour corriger les biais d'échantillonnage et la non-réponse.

Sources • Enquêtes ENEIS 2004 et 2009, DREES, exploitation CCECQA.

Causes systémiques ++

Lieux de survenue et métiers impliqués



Duclos, BMJ 2024

Rencontres HAS 2007





Une ergonomie déficiente
Pire, une (in)formation souvent déficiente

Ce qu'il faut retenir

- Les Evènements Indésirables Associés aux Soins (EIAS) sont **fréquents, endémiques**
- Les EIAS peuvent être **graves** et constituent l'une des principales causes de **mortalité**
- Les EIAS sont notamment **évitables** par la mise en place d'actions de **prévention quaternaire**
- Le **signalement ou la mesure** des EIAS est essentielle pour améliorer la sécurité des soins
- L'**analyse approfondie des causes** d'un EIAS permet de comprendre pourquoi une défaillance dans une organisation a occasionné un accident
- Il n'y a **pas forcement une « erreur humaine »** à l'origine de chaque EIAS
- L'analyse objective des faits est un prérequis essentiel pour **éviter la récidive** de risques favorisant la survenue d'EIAS

Bibliographie pour ce cours

Références insérées dans le diaporama

+

Les événements indésirables graves associés aux soins observés dans les établissements de santé : Résultats des enquêtes nationales menées en 2009 et 2004. Dossier solidarité Santé DREES N°17 2010

Surcoût des événements indésirables associés aux soins à l'hôpital . Question d'économie de la Santé http://www.irdes.fr/Publications/2011/Qes171.pdf

R. Amalberti Diaporama HAS : (https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/tr22_r._amalberti_2008_01_04__13_50_17_440.pdf)

Haute Autorité de Santé. Construction et utilisation des indicateurs dans le domaine de la santé : Principes généraux. 2002 : 39 pages. (https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2009-10/construction_et_utilisation_des_indicateurs_dans_le_domaine_de_la_sante_-_principes_generaux_guide_2002.pdf)